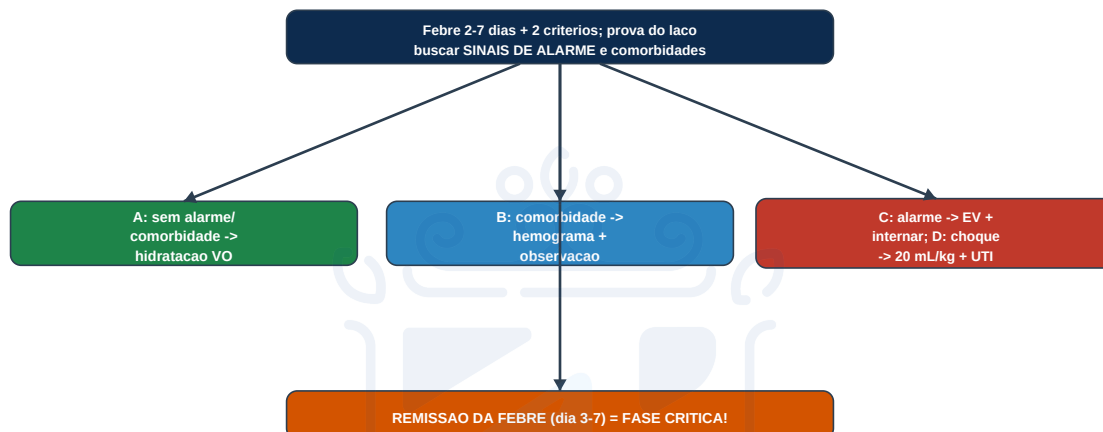


## DENGUE — GRUPOS A-D + HIDRATAÇÃO

### FLUXOGRAMA — GRUPO DEFINE A CONDUTA

#### DENGUE — CLASSIFICAR (A/B/C/D) E HIDRATAR



### DEFINIÇÃO, FASES E CASO SUSPEITO

#### RECONHECER A FASE

- Doença febril aguda por arbovírus (Aedes aegypti); fases: FEBRIL (2-7 dias), CRÍTICA (remissão da febre, dias 3-7 — risco de choque por extravasamento), RECUPERAÇÃO (reabsorção)
- Caso suspeito: febre (2-7 dias) +  $\geq 2$  de: náusea/vômito, exantema, mialgia/artralgia, cefaleia/dor retro-orbital, petéquias ou prova do laço +, leucopenia
- Criança: febre aguda (2-7 dias) sem foco aparente
- CHAVE: reconhecer sinais de alarme + hidratação adequada + CUIDADO na remissão da febre (fase crítica!)
- PROVA DO LAÇO (em todos): insuflar manguito na PA média por 5 min; positivo se  $\geq 20$  petéquias (adultos) ou  $\geq 10$  (crianças) em quadrado de 2,5 cm

### SINAIS DE ALARME (GRUPO C) E DE CHOQUE (GRUPO D)

#### O QUE NÃO PODE PASSAR

- ALARME: dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos (ascite/derrame); hipotensão postural/hipotímia; hepatomegalia  $> 2$  cm; sangramento de mucosa; letargia/irritabilidade; aumento progressivo do hematócrito
- CHOQUE: taquicardia, extremidades frias, pulso fino, enchimento capilar  $> 2$  s
- PA CONVERGENTE ( $< 20$  mmHg entre sistólica e diastólica) — sinal precoce de choque
- Hipotensão (tardia), oligúria ( $< 1,5$  mL/kg/h), taquipneia
- A remissão da febre marca o início da fase crítica — orientar retorno NO DIA em que a febre passar

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (DEFINE A CONDUTA)

| Grupo | Critério e conduta                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Sem alarme, sem comorbidade/risco social -> ambulatorial; exames a critério; hidratação oral + retorno                                       |
| B     | Sem alarme, COM comorbidade/condição especial (lactente, gestante, idoso, HAS/DM/cardiopatia/DRC etc.) -> hemograma OBRIGATÓRIO + observação |
| C     | COM sinais de alarme -> hemograma/albumina/transaminases; hidratação VENOSA + internação (mín. 48h)                                          |
| D     | Dengue grave (choque, sangramento grave, disfunção orgânica) -> expansão rápida + UTI                                                        |

## HIDRATAÇÃO — TRATAMENTO FUNDAMENTAL

### Rx POR GRUPO

A/B (oral): adultos 60 mL/kg/dia (1/3 SRO + 2/3 líquidos caseiros); crianças até 10 kg 130 mL/kg/dia, 10-20 kg 100 mL/kg/dia, > 20 kg 80 mL/kg/dia  
C (venosa): SF 0,9% 10 mL/kg na 1ª hora -> reavaliar (sinais vitais, diurese alvo 1 mL/kg/h); 2ª hora 10 mL/kg/h; se melhora -> manutenção 25 mL/kg em 6h, depois 25 mL/kg em 8h  
C sem melhora: repetir expansão (10 mL/kg/h) até 3x; se não melhorar -> Grupo D  
D (choque): SF 0,9% 20 mL/kg em até 20 min (bolus) -> reavaliar; se melhora, tratar como C  
D refratário com Ht em ELEVAÇÃO: expansores plasmáticos (albumina 0,5-1 g/kg, ou coloide 10 mL/kg/h); Ht em QUEDA: investigar hemorragia (concentrado de hemácias 10-15 mL/kg)  
PARAR/reduzir quando: fim do extravasamento, normalização de PA/pulso/perfusão, queda do Ht (sem sangramento), diurese normal — CUIDADO com excesso (edema pulmonar em idosos/cardiopatas)

## EXAMES E SINTOMÁTICOS

### LABORATÓRIO E O QUE NÃO USAR

- Hematócrito: aumento = hemoconcentração (extravasamento, alarme); normal/baixo sem sangramento = melhora
- Leucopenia comum; plaquetas em queda progressiva — NÃO transfundir plaquetas de rotina (só por critérios específicos)
- Grupos C/D: albumina (hipoalbuminemia), transaminases, função renal, eletrólitos, gasometria se choque
- Antitérmico/analgesia: Dipirona ou Paracetamol
- NUNCA: AAS e AINEs (ibuprofeno/diclofenaco/nimesulida) — risco de sangramento; evitar injeções IM (hematoma)

## CRITÉRIOS DE ALTA E ORIENTAÇÕES

### QUANDO LIBERAR

- ☐ Alta de internação (C/D) — TODOS os 6: estabilização hemodinâmica por 48h; afebril por 24h; melhora clínica; Ht normal/estável por 24h; plaquetas em elevação; diurese normal
- ☐ Alta A/B: retorno diário até 48h após a remissão da febre; retorno IMEDIATO se alarme; retorno no dia da defervescência (fase crítica); entregar cartão da dengue
- ☐ Orientar hidratação rigorosa mesmo sem febre; repouso; repelente
- ☐ Retorno imediato: dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento, tontura ao levantar, queda da diurese, sonolência/irritabilidade, dispneia, extremidades frias, ascite
- ☐ Sem defervescência: retornar no 5º dia de doença

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com dengue Grupo \_\_\_\_; febre há \_\_\_\_ dias, \_\_\_\_ remissão (fase \_\_\_\_); comorbidades \_\_\_\_.
- Alarme: \_\_\_\_ (dor abdominal/vômitos/hepatomegalia \_\_\_\_ cm/sangramento/hipotensão postural/letargia/hemoconcentração); choque: PA \_\_\_\_/\_\_\_\_, FC \_\_\_\_, enchimento capilar \_\_\_\_s.
- Sinais vitais \_\_\_\_, diurese \_\_\_\_ mL/kg/h; Ht \_\_\_\_% (variação \_\_\_\_), plaquetas \_\_\_\_; hidratação EV feita: \_\_\_\_ mL (\_\_\_\_ mL/kg) em \_\_\_\_h; resposta \_\_\_\_.
- Solicito internação em \_\_\_\_ (enfermaria/UTI) para hidratação/monitorização / expansão / transfusão.



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Em qual momento da dengue ocorre o maior risco de choque (fase crítica)?

- A) No primeiro dia de febre
- B) Na remissão da febre (entre o 3º e o 7º dia), por extravasamento plasmático
- C) Após a recuperação completa
- D) Antes do início da febre
- E) Apenas com plaquetas < 10.000

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual medicação é CONTRAINDICADA no tratamento sintomático da dengue?

- A) Paracetamol
- B) AAS e AINEs (risco de sangramento)
- C) Dipirona
- D) Soro de reidratação oral
- E) Repelente

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente com dengue e sinais de choque (Grupo D). Qual a conduta inicial de hidratação?

- A) SRO 60 mL/kg/dia
- B) SF 0,9% 20 mL/kg em bolus (até 20 min) com reavaliação
- C) Restrição hídrica
- D) Apenas observação
- E) Albumina isolada de imediato

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

No seguimento da dengue, o aumento do hematócrito indica:

- A) Melhora do quadro
- B) Hemoconcentração por extravasamento plasmático (sinal de alarme)
- C) Sangramento ativo
- D) Hidratação excessiva
- E) Normalidade

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a transfusão de plaquetas na dengue, é correto:

- A) Transfundir sempre que plaquetas < 50.000
- B) NÃO transfundir de rotina; reservar a critérios específicos (sangramento não controlado)
- C) Transfundir em todos os Grupos C
- D) Transfundir profilaticamente em todos
- E) É o tratamento principal

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

A fase crítica ocorre na remissão da febre (dias 3-7), quando o extravasamento plasmático aumenta o risco de choque — por isso se orienta retorno no dia em que a febre passar.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

AAS e AINEs são contraindicados pelo risco de sangramento; usa-se Paracetamol ou Dipirona. Também se evitam injeções IM (hematoma).

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

No Grupo D (choque), faz-se expansão rápida com SF 0,9% 20 mL/kg em bolus (até 20 min), reavaliando; se melhora, segue como Grupo C.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

O aumento do hematócrito indica hemoconcentração por extravasamento plasmático — sinal de alarme; a queda (sem sangramento) sugere melhora.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

Não se transfunde plaqueta de rotina na dengue, mesmo com plaquetopenia; reserva-se a situações específicas, como sangramento persistente não controlado.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico